

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Rabu / 06 Mei 2026
 PUKUL : 08.00 – 16.40 WIB
 AGENDA RAPAT : Survei Simulasi Akreditasi – Telusur
 (Manajemen)

PEMIMPIN RAPAT : dr. Lovi Krissadi Endari, MARS
 NOTULIS : Sherly Rosita, S. Kep. Ns
 TEMPAT : RS Prima Husada Malang

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	IRNA 5C	1) SPO cara pembersihan, dibawah tempat sampah / area kolong2. 2) Ada semut, disemprot CS, rentokil tdk fungsi. Evaluasi. 3) Kanebo untuk membersihkan troli, kanebo dicuci dimasukkan box, blm ada di SPO. 4) Pembuangan tempat sampah ditempatkan masuk didalamnya jangan tercecer. 5) Makanan pasien tidak ada etiket ada di meja makan, diberikan masih nanti, harusnya diberikan mendekati jam 10. Masuk KPC krn tdk ada etiket. 6) Label B3 di alkohol tudak ditempel dibotol spray. 7) Standar spoelhoek tiap ruangan hrs ada , perhatikan saat pembuatan RS baru. 8) Meja galon dikeluarkan diswitch dg troli injeksi diruang obat. 9) Ada sisa spuit banyak di troli, ada spuit selain bmhp lab (tdk direktur). Permintaan spuit ambil darah & botol sampling selama ini lgsg ke lab. Biayanya apakah sdh masuk BMHP tindakannya. 10) Tempat spuit di troli diperbaiki yg bagus. 11) Mencocokkan antara RM dengan PPK CP pasien TB. PPK menjadi catatan dokter terutama dokter IGD. 12) Box emergency peetakkannya tidak dekat dengan gunting dan tidak efisien terdapat 2 kunci kabel tis. Penulisan labeling juga tidak sesuai. 13) Penamaan alat di unit yg baik. 14) Perapian kabel colokan.	1) Review kembali SPO pembersihan dan monitoring karu di ruangan masing-masing. 2) Melakukan evaluasi pada rentokil. Cari sumbernya supaya tidak bertambah banyak. 3) SPO pembersihan kanebo setelah dipakai ditambahkan pada SPO pembersihan ruangan yg sudah ada. 4) Koordinasi dengan Kainstansi Gizi terkait jam pemberian makan sonde pasien. Lapor PMKP masuk KPC, investigasi sederhana. 5) Kelengkapan labeling diperhatikan kembali terutama pada wadah cairan B3 yang ada di unit pelayanan. 6) Standar fasilitas unit terkait MFK bangunan untuk pembuangan limbah cair infeksius. spoelhoek tiap ruangan hrs ada , perhatikan saat pembuatan RS baru. 7) Petugas ruangan wajib mengkondisikan ruangan dan merapikan barang2 yang ada diruangannya. 8) Diclearkan lagi koordinasi dg keuangan terkait bmhp lab dan alur baru yang efisien. 9) Perhatikan barang-barang yang ada di unit masing-masing, jika memang ada yang tidak sesuai/tidak layak/tidak indah, diganti dengan yang lebih baik. 10) Perbaiki PPK disesuaikan dengan temuan case mix. 11) Penataan kembali box emergency termasuk dengan labeling obatnya. Box emergency berisi obat sesuai standar, jika ada OKT kabel tis pengunci pakai warna merah. Jika tdk ada OKT warna putih. Peletakkan ditempat terjangkau, dekat gunting, hrs bersih, isi obat hrs dicek kadaluarsanya. Tulisan handscon di box emergency lbh baik dihilangkan. Perbaiki penulisan pada box emergency, perhatikan warna kertas dan bahannya agar terlihat. PJ Farmasi. Tulisan diperbarui dipermudah dengan urutan nomor atau abjad, peta diluar	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PJ BAB



		15) Kalibrasi alat kesehatan wajib ada.	diperbarui, diberi daftar isi sesuai nomer. Tdk perlu diberi plastik.	
			12) Koordinasi dengan IPSRS terkait penamaan barang, termasuk perbaiki kembali alur barang datang masuk ke IPSRS dan penamaan sekaligus penomoran alat sebagai data inventaris RS.	
2.	IGD	1) Cairan infus masih ada isi dibuang di tempat sampah. 2) Dimeja IGD hanya ada tulisan akrilik "Dokter Jaga", tidak tertulis namanya. 3) ALat baca foto rontgen tidak tertulis Ready. 4) Form ceklist maintenance alat monitor user tidak seragam dan ada yang tidak diisi, kabel alat kotor. 5) Tempat sampah infeksius, terlalu banyak. Pemilahan sampah jg belum benar.	1) Karu lebih kontrol lagi unitnya, IPCLN juga kontrol kepatuhan pembuangan limbah cair dan padat. 2) Diberikan papan jaga dokter yg bertugas hari ini seperti di poli pakai akrilik, akan didesain. 3) Kalibrasi dan tulisan "Ready" alat baca rontgen, siap pakai diperbarui. 4) Form ceklist maintenance alat monitor user diperbaiki dan petugas membersihkan. 5) Pengurangan jumlah tempat sampah dan peletakkan yang baik.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PJ BAB 5) PKRS
3.	Lift gd A	1) Di lift diberi tulisan prima husada grup, phm, phs, rsdh, rs k, untuk pengenalan promotif	1) Bentuk promotif RS.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PKRS
4.	Saran	Monitoring yg dilakukan mandiri setiap hari:	Tiap ruangan cek: 1) Kelengkapan Wastafel (harus ada tissu, handwash) 2) Box B3 (harus ada label bahaya, mudah terbakar, dll) 3) Apar 4) Sampah (pemilahan tepat) 5) Kalibrasi alat terpasang 6) Box emergency (tdk ada obat yang ED)	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PJ BAB
5.	Irna 7A	1) Lemari petugas berisi barang-barang tidak perlu dan tidak beraturan. 2) Penamaan barang tidak indah dan seragam, pakai spidol tidak beraturan, tidak ada nomor inventaris. 3) Langit2 kotor ada sawang2. 4) Pembersihan permukaan meja pakai air sabun. Alkohol untuk alkes. 5) Suhu ruangan tidak standar. Suhu yg tidak sesuai, IPSRS hrs bergerak. 6) Ruang obat, dibedakan dengan lemari. 7) Bed pasien dan nakas setelah dibersihkan ditata rapi supaya tau sdh ready bersih.	1) Penataan lemari, jangan dicampur milik pasien dan petugas. Barang yang tidak perlu disingkirkan saja. 2) Perbaikan SPO penerimaan barang, penamaan barang & penomoran seragam dari ipsrs. 3) Pembersihan ruangan lebih menyeluruh area yang tidak terjangkau. 4) Pemahaman kembali proses pembersihan ruangan terutama permukaan meja di unit. 5) Koordinasi dengan IPSRS untuk pengecekan suhu ruang, dibuatkan stiker standar suhu normal sebagai patokan teman-teman unit dan ditempel di alat ukur suhu ruang. 6) Kebijakan PT, jika membutuhkan ruangan untuk tempat obat rawat inap, mengingat kondisi ruangan yang tidak memungkinkan ada ruang lagi, bisa memakai inisiatif dengan membedakan tempat penyimpanan berupa almari. Kecuali memang diharuskan tempat khusus seperti LAF.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PJ BAB



			7) Standarisasi proses pembersihan ruangan setelah pasien KRS, penataan harus diperhatikan agar seragam dan benar dipastikan sudah dibersihkan, perawat unit juga wajib konfirmasi.	
6.	Farmasi	1) Obat Pasien OB etiketnya tidak dipasang di masing-masing obat. 2) Maintenance alat kurang (CPU Monitor tidak terisi monitoringnya) 3) Label B3 tdk ada.	1) Obat OB disiapkan terpasang dengan isolasi. 2) Koordinasi IPSRS keseragaman form monitoring, dan kepatuhan monitoringnya. 3) Cairan B3 di lemari B3 wajib dikontrol harus ada stiker tanda bahaya B3. Karu kontrol rutin, MFK monitoring berkala.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PJ BAB
7.	Poli paru	1) Tambahkan cara pengambilan sputum. 2) Kabel-kabel diatas tempat pengambilan dahak dirapikan. 3) Terpasang papan edukasi kolesterol di ruang TB. 4) Belum ada keterangan ketentuan yang harus dilakukan oleh pasien paru (TB), misal wajib pakai masker. 5) Jika ada kekosongan obat TB, dirujuk. 6) Jika membutuhkan ruang isolasi, isolasi penuh? 7) Jika ada obat hibah dari dinkes, tidak perlu dimasukkan SO RS. 8) Promosi kesehatan dari perawat, dibuat video untuk edukasi pasien TB. 9) Safety box dinamai nama unitnya saat merakit. 10) Tidak ada stiker ready pada alat 11) Form pinjam spirometer diganti elektronik. 12) Stempel dokter tidak terpakai masih disimpan unit. 13) Panel listrik, tanda bahaya stikernya terlalu kecil. 14) Kursi roda depan poli gak ada resiko jatuh	1) Dibuatkan stiker cara pengambilan sputum dan ditempel di tempat pengambilan dahak. 2) Koordinasi IT perapian kabel. 3) Papan edukasi di ruang TB disesuaikan, terkait TB jgn kolesterol. 4) Dipintu depan ruang TB ditambah stiker area wajib masker. 5) Dipahami kembali alur jika terjadi kekosongan obat TB. 6) Jika membutuhkan ruang isolasi, isolasi penuh, kohorting ruang ventilasi baik. R. Isolasi igd hanya 1, px yg stabil bisa lgsg ke ruang isolasi. 7) Alur penerimaan obat hibahan diperbaiki. 8) Peningkatan program prognas terutama TB terkait promosi kesehatan. 9) Karu unit dan PJ unit harus cek penempatan alat2/barang2 yang ada di unitnya masing-masing. 10) Form-form yang masih dalam bentuk kertas, diperbaiki menggunakan form elektronik. 11) Stempel dokter yg sdh tdk terpakai diserahkan SDM, untuk diproses ulang. 12) Panel listrik diberi tanda bahaya yg jelas dan terbaca. 13) Pemasangan bendera resiko jatuh pada kursi roda yang belum ada.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PJ BAB 5) IT
8.	TPS B3	1) Stiker telpon di TPS B3 blm update. 2) Pemilhan sampah dibetulkan. 3) Alur pengambilan sampah	1) Perbaruan Stiker informasi telp petugas yang ada di TPS B3. Ext security diganti jadi 128. 2) Perbaiki alur pengambilan sampah, koordinasi dengan CS. CS memakai APD dari unitnya, mengambil troli sampah, keliling mengambil sampah, dan membawa ke TPS B3 sudah memakai APD.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Unit terkait 4) PJ BAB
9.	IKO, IRNA 2C	1) Penandaan area operasi di ERM diperbaiki, disesuaikan, ditetapkan pakai tanda apa. 2) Tempat sampah di bawah wastafel ruang perawat dihilangkan saja. 3) Belum ada kualifikasi khusus dari IKO untuk rekrutmen internal. 4) Logbook penilaian di IKO untk staf orientasi belum ada.	1) Koordinasi dengan tim SKP dan simrs untuk penandaan. Koordinasi dengan SIMRS juga agar seragam untuk semua unit. 2) Jk ada pasien TB, trs perlu operasi, diclearkan alurnya. 3) Skrining pasien menular hrs clear di igd. 4) IKO kualifikasi khusus (bisa dipakai untuk rekrutan internal): maks usia 40th, tidak bau badan, good looking, punya sertifikat instrumen/anestesi, mau diajak kerjasama, komitmen, siap dengan segala konsekwensi di IKO. 5) Logbook penilaian di IKO untk staf orientasi: contoh yg dilihat: Inputan tidak	5) Direktur 6) Kabid 7) Kepala Unit terkait 8) PJ BAB



	5) Bedakan evaluasi kinerja dengan supervisi penilaian. Supervisi disepakati tiap minggu, evaluasi 1 bln. 6) Staf yg melebihi kewenangannya dijadikan bahan evaluasi komkep. 7) Alur pembuangan darah misal pada tabung suction. 8) Di hasil map CT Scan pasien diletakkan di map keranjang, di map keranjang diberi tulisan RM aktif. 9) Pihak ke 3 IKO, MOU nya hrs ada mutunya. 10) Recall alkes: alurnya harus jelas (MFK) 11) Proses penerimaan staf baru? 12) Irna 2c kualifikasi khusus (bisa dipakai untuk rekrutan internal irna): terampil, care ke pasien, komunikasi baik, good looking, tatak. 13) Perawat anisa bisa cuci tangan, lupa lepas jam tangan. 14) Suhu ruang obat di 2c blm ada, AC blm terpasang. 15) Buat daftar penyakit immunocompromised yg bisa diserahkan ke pdf igd terkait penggunaan ruangan.	tepat, penyiapan instrument kurang tepat, perhitungan saat ada tukar jadwal, moody saat kerja, tdk profesional, penampilan ok dan tdk bau badan, tidak lemot (cepat tanggap), komunikasi baik. Bisa dimasukkan pada kualifikasi pedoman pengorganisasian IKO). 6) Form delegasi untuk tindakan yg seharusnya dikerjakan dokter tapi dikerjakan perawat dituliskan di form kredensial. 7) Buat video petugas memperagakan dengan menggunakan APD yang sesuai. 8) Evaluasi MOUnya (6 PKS) (panca otr boss cakra fitra Sam): keterlambatan penyediaan barang. Dalam TKRS, pks terkait pelayanan medis (kabid pely/pengadaan), selain itu bisa ke humas. 9) Proses penerimaan staf baru: penerimaan, tes seleksi, kontrak muncul sbg apa perawat, orientasi umum, kredensial, sk penempatan ruangan, orientasi khusus, evaluasi kinerja oleh karu. 10) Koordinasi IPSRS untuk pemasangan outdoor AC. 11) Akan segera dibuatkan daftar contoh penyakit immunocompromised dan diserahkan ke pendaftaran dan ruang rawat inapnya.	
--	--	---	--

Surveior Manajemen,

dr. Lovi Krissadi Endari, MARS

Malang, 06 Mei 2026

Notulis,

Sherly Rosita, S. Kep. Ns

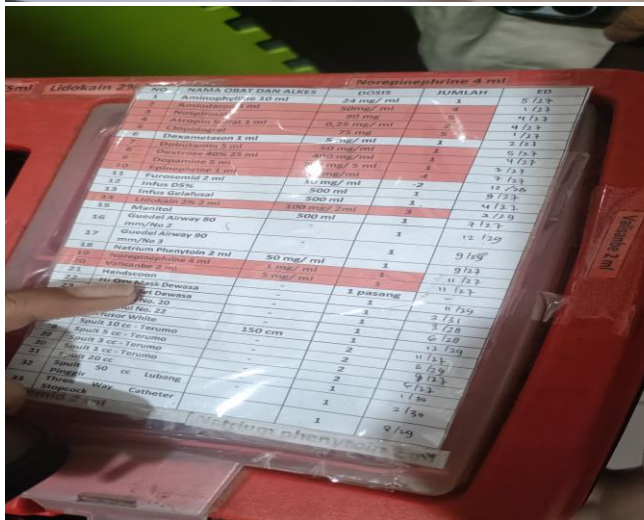
Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

DOKUMENTASI















NOTULEN

HARI / TANGGAL : Kamis / 07 Mei 2026
PUKUL : 08.00 – 15.30 WIB
AGENDA RAPAT : Suvei Simulasi Akreditasi – Telusur
(Manajemen)

PEMIMPIN RAPAT : dr. Lovi Krissadi Endari, MARS
NOTULIS : Sherly Rosita, S. Kep. Ns
TEMPAT : RS Prima Husada Malang

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Gizi	1) Penataan bumbu2 masih bercampur, bingung untuk mencari. 2) Suhu ruang di dapur belum standar masih diatas 28 derajat. (Ruang gudang kering) 3) Alur alat makan bersih belum sesuai. Dimanfaatkan gedung yang ada sekarang dg cara yg tetap bisa masuk standar. 4) Alas karet didapur membahayakan. Diganti diperbaiki. 5) Pembersihan rak2 didapur masih kurang, kompor sudah rutin bersih tinggal keraknya. Termasuk gudang kering. Penataan bahan makanan di rak perhatikan jarak. 6) Label stiker B3 blm terpasang. Efisiensi label B3, sekali pakai. Saran sudah ada tempat dahulu yg sudah dilabeli di unit, dan tinggal dikeluarkan dari kemasan lgsg dimasukkan wadahnya. 7) Stok box makan terlalu banyak. 8) Print diet masih manual kertas. 9) Master data ceret plastik di stop, diganti yg lebih baik.	1) Penataan bumbu2 diperhatikan ditata rapi, termasuk didalam kulkas. Kelompokkan sesuai dengan jenisnya supaya mudah mencari. 2) Perhatikan cara menjawab yg yakin supaya tidak menjadi pertanyaan. 3) Box makanan stok dikembalikan ke pengadaan diserahkan RSCK. Box rusak dibuang saja atau dimanfaatkan untuk tempat bumbu. 4) Print diet yg dipakai untuk jelaskan dirubah sistem elektronik hp. 5) Konfirmasi pengadaan untuk tutup master data permintaan ceret plastik, diganti yang lebih baik.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Ruang 4) PJ BAB
2.	CSSD	1) Label di lemari alat salah. 2) Serah terima alat diperbaiki lg dimasukkan sistem SIMRS. 3) Kebersihan ruangan, ada sawang diatas korden. 4) Lokasi savety box diperbaiki.	1) Diperbaiki label lemari yang lebih baik dan sesuaikan isinya. 2) Koordinasi dengan SIMRS terkait orderan alat & serah terima alat steril dimasukkan kedalam SIMRS. 3) Pembersihan ruang ditingkatkan & peletakkan safety box harus dibenarkan supaya mudah dijangkau.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Ruang 4) PJ BAB
3.	Gudang umum	1) Isolasi terlalu banyak, yg terlalu mahal pilih salah satu yg lbh murah fungsinya tetap bisa digunakan.	1) Pemilahan penyimpanan barang-barang digudang umum yang sudah lama stop order tapi masih ada sisa	1) Direktur 2) Kabid



		2) Lakban warna warni distop order. 3) Barang yg msh ada stok tp sdh stop order, dikumpulkan supaya tidak bingung mana yg msh barang lanjut mana yg sdh distop. 4) Buku TTV / ekspedisi master ditutup untuk diganti dengan spreadsheet di hp.	dengan stok barang yang masih moving supaya mempermudah controlling. 2) 2 atau lebih barang yang fungsinya sama, pilih salah satu yg lebih efisien, master barang yang tidak dipakai di hapus. 3) Digitalisasi ditingkatkan untuk menunjang program efisiensi.	3) Kepala Ruang 4) PJ BAB
4.	Gudang farmasi	1) Stiker simbol B3 blm semuanya rata terpasang, betadine blm terpasang. 2) Eye washer kurang memancar airnya & pijakannya tdk otomatis kembali. 3) Sterile water 1000 cc, terlalu banyak di gudang atas. 4) Wawancara kepuasan vendor, 5) Stiker jadwal kunjungan dirubah, karena berbelit dan kurang informatif.	1) Perbaiki fasilitas dan monitoring labeling B3 di gudang farmasi. 2) Perbaiki terkait jumlah orderan jgn banyak2 jika memang slowmoving. 3) Perbaruan stiker, sesuaikan dengan fungsi informatifnya, pilih bahasa yang mudah dipahami dan to the point. kunjungan setiap hari apa & ditambah tdk menerima kunjungan principal bisa lgsg ke kantor PT, kebutuhan dokumen silahkan langsung dengan PT.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Ruang 4) PJ BAB
5.	Laundry	1) Tembok berjamur. 2) AC tidak dingin. 3) Tulisan tong linen bersih diganti troli linen bersih stiker yang baik.	1) Perbaiki fasilitas dan bangunan. 2) Tingkatkan pemeliharaan fasilitas. 3) Labeling penamaan barang diperbaiki kembali.	1) Direktur 2) Kabid 3) Kepala Ruang 4) PJ BAB

Surveiyo Manajemen,

Malang, 07 Mei 2026

Notulis,

dr. Lovi Krissadi Endari, MARS

Ns. Sherly Rosita, S.Kep

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M. Kes



DOKUMENTASI





